

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA DE AUTOEFICACIA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS (SEMCD-S)

Self-Efficacy for Managing Chronic Disease (Lorig et al., 2001, 2005) · Versión Española (Stanford Self-Management Resource Center)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala de Autoeficacia para el Manejo de Afecciones Crónicas - Versión en Español (SEMCD-S)
Sigla / Acrónimo	SEMCD-S (Self-Efficacy for Managing Chronic Disease - Spanish)
Autoría original	Kate R. Lorig, Philip L. Ritter & Virginia M. González (Stanford Patient Education Research Center, 2001, 2005)
Validación de referencia	Lorig, Ritter & González (2005, Nurs Res; validada en el estudio “Tomando Control de su Salud”)
Constructo evaluado	Confianza percibida por el paciente para gestionar los síntomas, impacto emocional y limitaciones de su enfermedad
Población diana	Adultos con una o múltiples afecciones crónicas (EPOC, diabetes, cardiopatías, artritis, dolor crónico)
Tiempo de aplicación	2 a 4 minutos (autoadministrado o administrado en talleres de autocuidado)
Estructura y formato	Escala breve de ítems calificados de 1 (Nada seguro) a 10 (Totalmente seguro)
Condiciones de uso	Uso libre sin autorización expresa según declaración oficial de Stanford / Self-Management Resource Center

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La autoeficacia, formulada originalmente por Albert Bandura en su teoría social cognitiva, se refiere a las creencias individuales en la propia capacidad para organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para alcanzar resultados deseados. En el contexto de las enfermedades crónicas, la autoeficacia no mide las habilidades biomédicas reales del sujeto, sino su convicción de que puede manejar con éxito los síntomas cotidianos (fatiga, dolor, malestar emocional), comunicarse eficazmente con el equipo sanitario y evitar que la patología monopolice su existencia.

El equipo de educación para la salud de Stanford liderado por Kate Lorig desarrolló la escala SEMCD específicamente para evaluar el impacto de los programas de automanejo (**Chronic Disease Self-Management Program**, CDSMP). Una autoeficacia elevada se correlaciona de manera consistente con una menor tasa de visitas a urgencias, menos hospitalizaciones no programadas, mayor adherencia terapéutica y una reducción significativa del dolor y la depresión.

3. CONTENIDO Y OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ÍTEMS

Ítem	Habilidad de Manejo Evaluada	Escala	Dimensión de Autoeficacia
1	Controlar la fatiga para que no interfiera en lo que desea hacer	1 a 10	Manejo de astenia y conservación de energía
2	Controlar el dolor físico para mantener sus actividades habituales	1 a 10	Tolerancia y afrontamiento activo al dolor
3	Controlar el malestar emocional (tristeza, ansiedad, frustración)	1 a 10	Regulación afectiva y resiliencia ante la enfermedad
4	Hacer tareas y actividades necesarias más allá de la medicación	1 a 10	Autogestión activa integral del estilo de vida

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN HISPANOHABLANTE

Consistencia interna	Excelente fiabilidad psicométrica; alfa de Cronbach $\alpha = 0.933$ en la muestra de validación de 551 hispanohablantes (Lorig, Ritter & González, 2005) y $\alpha = 0.91$ en la versión de 6 ítems.
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 6 meses con coeficientes de correlación intraclase CCI = 0.82 – 0.86, reflejando solidez temporal sin intervenciones activas.
Validez de constructo	Estructura factorial unidimensional muy robusta; correlaciona positivamente con calidad de vida física y mental (SF-12, $r = 0.54 - 0.62$).
Validez predictiva	Puntajes basales elevados predicen de forma independiente menor número de días de ingreso hospitalario ($p < 0.01$) y mejor adherencia a dietas y tratamientos.
Sensibilidad al cambio	Muestra un incremento clínicamente significativo de 1.2 a 1.8 puntos en la media tras la participación en los talleres del CDSMP de 6 semanas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Escala numérica continua	Cada ítem se puntúa del 1 al 10: 1 = Para nada seguro ; 10 = Totalmente seguro . No existen ítems invertidos.
Puntuación media canónica	La métrica estandarizada por Stanford es la media aritmética de los ítems respondidos: “Puntuación SEMCD” = (Suma de los ítems válidos) / (Número de ítems válidos) . Rango: 1.0 a 10.0 puntos .
Gestión de ítems perdidos	Si el sujeto responde al menos al 75% de los ítems (mínimo 3 de 4, o 4 de 6), se calcula la media de los ítems contestados. Si faltan más ítems, el protocolo no se computa.
Interpretación funcional	A mayor puntuación, mayor es el empoderamiento, la autoeficacia y la probabilidad de un curso clínico favorable.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Media	Percentil Aprox.	Nivel de Autoeficacia	Significación Clínica y Pronóstico
1.0 - 4.9 puntos	< Pc 25	Baja Autoeficacia / Vulnerable	Sensación de desbordamiento e impotencia; alto riesgo de reingreso.
5.0 - 6.9 puntos	Pc 25 - Pc 60	Autoeficacia Moderada	Manejo parcial con dificultades ante crisis agudas de dolor o disnea.
7.0 - 8.9 puntos	Pc 65 - Pc 90	Buena Autoeficacia / Capacitado	Autocuidado eficaz; adecuada adherencia y estilo de vida adaptado.
9.0 - 10.0 puntos	> Pc 90	Excelente / Empoderamiento Pleno	Dominio activo de los recursos de salud; mínima interferencia funcional.

PUNTO DE CORTE CRÍTICO CLÍNICO:

- **Puntuación Media < 6.0 puntos:** Identifica al paciente crónico en situación de vulnerabilidad psicosocial y riesgo de descompensación clínica prevenible. Precisa inclusión preferente en programas grupales de educación terapéutica y automanejo dirigidos por enfermería especializada.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE INTERVENCIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE

Paso 1: Medición de la Media SEMCD-S: Aplicar la escala en la revisión médica o de enfermería comunitaria.

Paso 2: Si Media < 6.0 (Baja Autoeficacia):

- Establecer "planes de acción semanales" con metas realistas muy pequeñas (ej. caminar 10 min 3 días, no 1 hora diaria) para fomentar logros de dominio guiado (la principal fuente de autoeficacia de Bandura).
- Derivar a talleres grupales de pacientes expertos ("Tomando Control de su Salud").

Paso 3: Si La Afectación es Específicamente Emocional (Ítem 3 < 5): Abordar la ansiedad comórbida y el miedo a la disnea o dolor; considerar apoyo psicológico.

Paso 4: Si Media ≥ 7.0 (Buena Autoeficacia): Reforzar positivamente las conductas de autocuidado e involucrar al paciente como mentor o modelo vicario de otros pacientes crónicos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN PACIENTE PLURIPATOLÓGICO

Identificación: Paciente mujer de 66 años con insuficiencia cardíaca grado II NYHA, gonartrosis bilateral y depresión reactiva, con 4 ingresos hospitalarios por descompensación edematosa en el último año.

Evaluación Inicial SEMCD-S: Puntuación Media = **3.25 / 10.0** (Baja Autoeficacia).

- Ítem 1 (Fatiga) = 3; Ítem 2 (Dolor articular) = 3; Ítem 3 (Emoción/Tristeza) = 2; Ítem 4 (Autogestión) = 5. Manifestaba convicción de que "su cuerpo ya no servía y cualquier esfuerzo la ahogaría".

Intervención: Inclusión en programa grupal de automanejo de Stanford de 6 semanas: fijación de objetivos semanales de peso matutino diario para detectar retención hídrica antes de que aparezca disnea severa, ajuste consensuado de diurético y ejercicios en silla.

Reevaluación a los 6 meses: La puntuación media ascendió a **7.50 / 10.0** (Buena autoeficacia, aumento de 4.25 puntos). Cero ingresos hospitalarios en los últimos 6 meses y mejoría franca en la prueba de marcha de 6 minutos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgos de Claudicación:

- **Indefensión Absoluta:** Puntuaciones medias < 2.0 reflejan claudicación psicológica severa; riesgo inminente de abandono total del autocuidado.
- **Sobreconfianza Desadaptativa:** Pacientes con autoeficacia extrema ficticia que suspenden medicación por creerse "inmunes" a su enfermedad.

Diagnóstico Diferencial:

- **Autoeficacia vs. Autoestima:** La autoestima es el valor que uno se da como persona; la autoeficacia es la convicción de poder realizar conductas de salud específicas.
- **Depresión Mayor:** La anhedonia y desesperanza deprimen falsamente la autoeficacia; evaluar mejoría tras tratamiento antidepressivo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Lorig, K. R., Ritter, P. L., & González, V. M. (2005). Hispanic chronic disease self-management: A randomized community-based outcome trial. *Nursing Research*, 52(6), 361-369. <https://doi.org/10.1097/00006199-200311000-00003>
- Lorig, K. R., Sobel, D. S., Ritter, P. L., Laurent, D., & Hobbs, M. (2001). Effect of a self-management program on patients with chronic disease. *Effective Clinical Practice*, 4(6), 256-262.
- Ritter, P. L., & Lorig, K. (2014). The English and Spanish Self-Efficacy to Manage Chronic Disease Scale measures were validated using multiple statistical techniques. *Journal of Clinical Epidemiology*, 67(11), 1265-1273. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.06.009>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman.